



1

55. ÅRGANG | 01 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Angst

PPT nr. 1-2018

**Projekt Hjælp til Selvhjælp
i Lyngby-Taarbæk kommune**

Af Jennifer Therese Løth

Projekt Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk kommune



Denne artikel er en beskrivelse af erfaringer fra et selvhjælpsprojekt rettet mod forældre, hvis børn har angst. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Center for Angst på Institut for Psykologi og PPR i Lyngby-Taarbæk Kommune. Artiklen beskriver hvilke refleksioner og erfaringer, der er opstået før, under og efter implementeringen. Formålet med artiklen er at videregive praksisnær viden om, hvordan et koncept rettet mod børn med angst, kan implementeres i en PPR. Hensigten er også at pege på, hvordan konceptet er et konkret bud på et tiltag, der giver nye muligheder for opgaveløsningen i PPR. En opgaveløsning, der retter sig mod borgernes behov.

*Af Jennifer Therese Løth, cand.psych.,
psykolog i PPR Lyngby-Taarbæk Kommune*

Nærværende artikel er en praksisartikel om programmet Hjælp til Selvhjælp, som også beskrives af Christiansen, Esbjørn og Breinholst (herefter: Christiansen et al., 2017) i dette nummer.

PPR Lyngby-Taarbæk kommune

For at forstå efterfølgende beskrivelser og refleksioner findes det nødvendigt, at læseren får et indblik i, hvordan PPR er organiseret i Lyngby-Taarbæk. Vi er i alt 13 psykologer samt en psykologfaglig leder, der tilsammen udgør PPR. PPR er organiseret i Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP).

Psykologerne er fysisk placeret på skolerne, hvilket imødekommer Kommunernes Landsforenings pejlemærker¹ om behovet for, at psykologen er

decentralt placeret (KL, 2013). Fordeling af sagerne i PPR foregår ikke centralt, men ude på den enkelte skole, hvor det er et samarbejde mellem forældre, skoleleder og psykolog, der fører til indstilling til PPR. De fleste skoler har én primær psykolog, mens enkelte har to tilknyttet. Vores opgaver er afgrænsede med tid fordelt på skoler og daginstitutioner.

De angste børn

Følgende er et tilbageblik på situationen inden samarbejdet mellem Center for Angst og Lyngby-Taarbæk kom i stand.

Vi kontaktede Center for Angst i foråret 2016, med henblik på et foredrag om børn og angst. Dette blev foranlediget af, at gruppen som helhed oplevede at få mange henvendelser om børn, der blev beskrevet som angste og/eller særligt sensitive af deres forældre, skolen eller begge. I de tilfælde hvor der blev

1 KL udarbejdede i 2013 en rapport, med formålet, at identificere pejlemærker for, hvordan PPR bedst muligt understøtter og bidrager til inklusionsarbejdet i kommunernes dagtilbud og skoler.

foretaget en pædagogisk psykologisk vurdering, viste det sig at børnene beskrevet som særligt sensitive, ofte opfyldte kriterierne for én eller flere angstlidelser. Børn med angst falder ofte mellem flere stole, da der sjældent er tilbud til dem, og da de ikke kan modtage tilskud til psykologbehandling via en henvisning fra egen læge (Psykologeridanmark, 2017).

Angstlidelser er en af de hyppigst forekommende psykiatriske lidelser i barndommen. De hyppigste forekommende angstlidelser er separationsangst, specifik fobi, socialangst og generaliseret angst (Esbjørn et al., 2016b). Vi ønskede derfor, som gruppe at få nogle konkrete redskaber til håndteringen af dette i en PPR-kontekst. Oplægget var derfor målrettet PPR's praksis, samt hvordan vi inden for en ramme af op til fem samtaler, kunne gøre en forskel for disse børn. Efter oplægget var det op til gruppen at få bragt den nye viden i spil, det viste sig at være vanskeligt, især da fem samtaler med hvert enkelt barn og familie, ville være for tidskrævende set i forhold til øvrige opgaver.

Angst eller særligt sensitiv?

Flere børn beskrevet som særligt sensitive har som nævnt også fyldt en del på skolerne i Lyngby-Taarbæk, og herunder også i PPR's praksis. På baggrund af denne forståelse, har der i mange tilfælde været et fokus på at skærme de børn der beskrives som særligt sensitive. Børnene har derfor oftest ikke deltaget i samme aktiviteter som deres jævnaldrende, da forældrene har forsøgt at skærme børnene for stress og belastninger. Anvendelsen af begrebet

særligt sensitiv har mange steder været udbredt, på trods af det forskningsmæssigt er mangelfuldt belyst, og kan dække over psykiske lidelser herunder angst. Såfremt der er tale om en angstlidelse, kan denne fastholdes og udvikles, hvis forældrene fortsat skærmer barnet, og barnet ikke understøttes aldersrelevant (Esbjørn et al., 2016b). I praksis har vi oplevet, at det med denne tilgang ofte er gået den anden vej, hvor børnene ofte er blevet skærmet hyppigere og i flere situationer, frem for det modsatte. Det har derfor også været væsentligt at få viden og redskaber til at undersøge og hjælpe børn, der beskrives som særligt sensitive, for at afdække hvad der ligger bag denne beskrivelse, så børnene hjælpes bedst muligt.

Projekt Hjælp til Selvhjælp

Efter vores oplæg i foråret 2016, fortsatte kontakten mellem Center for Angst og Lyngby-Taarbæk. Da Center for Angst skulle bruge en kommune til at afprøve deres projekt: Hjælp til Selvhjælp (herefter HSH), og det var et stort ønske i Lyngby-Taarbæk kommune at hjælpe børn med angst, blev et samarbejde etableret. Som beskrevet i Christiansen et al. (2017) er HSH et gruppebaseret selvhjælpsprogram, rettet til forældre hvis børn har angst. HSH baserer sig på kognitive adfærdsterapeutiske principper.

At tænke ind i boksen

I PPR er sagerne mangeartede og der er sjældent samme løsning på problemerne. Viden og løsninger genereres i et samarbejde mellem forældre, skole og psykolog. Ofte er det nødvendigt i

en PPR at trives med, at løsningerne ikke er givet på forhånd, da arbejdet ellers kan føles overvældende.

Med HSH var løsningen lavet for os. Der var ét program, og dette program var det, der blev brugt. I stedet for at skulle tænke ud af boksen, skulle vi nu tænke ind i en boks, der var givet på forhånd. Dette krævede en omstilling hos nogle af psykologerne. Dette fordi boksen ikke indeholder de redskaber vi normalt benytter os af, og hvor vi sædvanligvis arbejder ud fra en skolekontekst, skulle vi nu arbejde med forældrene.

Derudover var det med en vis skepsis for nogle af os, at forældrene skulle bruges som primære personer i behandlingen af deres børns angst. Det er dog ikke så nyt, da der siden slutningen af 1960'erne er sket et skifte i fokus, fra at fokusere på at ændre barnets adfærd, til at ændre forældrenes adfærd. Dette har ført til udviklingen af programmer rettet til forældre med forskelligt indhold (Kaminski et al., 2008). I Danmark er der også fokus på programmer til forældre. Programmerne har forskellige målgrupper, f.eks. forældre til børn med ADHD, depression, udadreagerende adfærd o.lign. Fælles for programmerne er at målet er at styrke forældrenes kompetencer, og muligheder for at støtte og hjælpe deres børn (Socialstyrelsen, 2017). Som også beskrevet i Christiansen et al. (2017), er det også en væsentlig del af HSH, at styrke forældrenes tro på egen mestring, og hjælpe dem med at udvikle kompetencer til at behandle deres børn.

Undersøgelser viser, at forældrenes egen angst og adfærd påvirker barnets

udvikling af angst (Yap et al., 2016).

Derfor er en intervention rettet mod forældrene til børn med angst, også relevant. Behov for forebyggende behandlingsforløb for børn og deres familier er ligeledes et pejlemærke i KL's rapport, idet brugerne af PPR oplever, at der er behov for dette. Derudover har psykologerne i PPR som udgangspunkt de faglige kompetencer til at have forebyggende behandlingsforløb, hvilket bør anvendes (KL, 2013).

Træning på Center for Angst

De deltagende psykologers udgangspunkt var forskelligt. Nogle havde erfaring med at arbejde kognitivt og specifikt med Cool Kids materialet, andre havde ikke erfaring med dette. Træningen bestod af 15 timers kursus om kognitiv adfærdsterapi til børn med angst, udover de 15 timer var der introduktion til HSH. Introduktionen til HSH indebar blandt andet øvelse i at holde workshops, at kunne svare på forældrenes spørgsmål, samt øvelse i brugen af manualerne. Metoderne under introduktionen var blandt andet rollespil, samt konkrete øvelser ud fra cases, hvor vi skulle anvende materialet fra Cool Kids. Derudover var der fastlagte supervisioner mellem workshopsne. Supervisionen var både orienteret omkring programmet, forældrene, børnenes beskrevne vanskeligheder, men også omkring dilemmaet med at se bort fra faktorer omkring f.eks. et skolemiljø, som vi ellers ville arbejde med. Da vi var færdige med kurset havde forskellene i erfaringer blandt psykologer ikke en væsentlig betydning.

Kort om projektet

Forskningsprojektet omfattede børn i alderen 1.-3. Klasse. Familierne blev dels rekrutteret via informationsbreve i deres E-boks, og dels via forældreaf-tener på skolerne varetager af Center for Angst. Tilmeldinger til projektet blev sendt direkte til en udviklingskon-sulent i CUP, der stod for alt praktisk med kontakt til forældre og Center for Angst. Flere forældre end forventet til-meldte sig projektet, og det blev derfor besluttet at oprette en sjette gruppe, i stedet for de oprindelige fem planlagte.

Hver gruppe bestod af op til 8 famili-er, hvor børnene havde moderat angst.

Børnenes angstniveau blev vurderet ud fra RCADS (Short-version)². Som beskrevet i Christiansen et al. (2017) deltog forældrene i to workshops af to timers varighed, som blev varetager af to PPR-psykologer, der havde deltaget i den indledende træning på Center for Angst. Herudover havde forældrene også mulighed for at blive tilknyttet en Facebookgruppe, hvori der blev postet ugentlige opslag vedrørende de afslut-tede sessioner, samt gav mulighed for indbyrdes erfaringsudveksling.

Undervejs

Om forældregruppen kan man samlet set sige, at størstedelen af de tilmeldte var veluddannede forældre, der var meget engageret i deres børns liv.

Gruppen er sammenlignelig med den gruppe der deltog i pilotprojektet på Center for Angst. Her var forældrene overvejende veluddannede med mode-rat til høj indkomst, og var motiveret for at deltage (Esbjørn et al., 2016a)

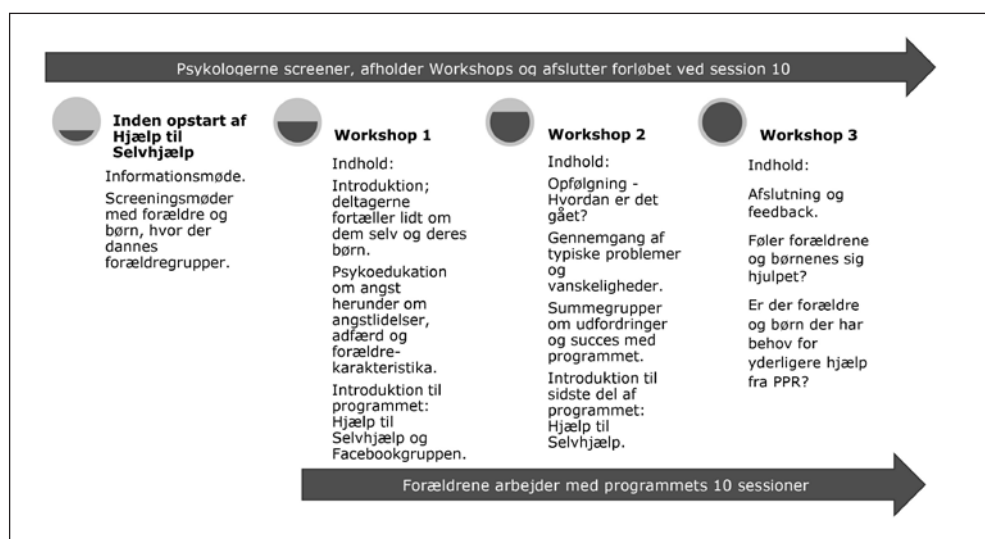
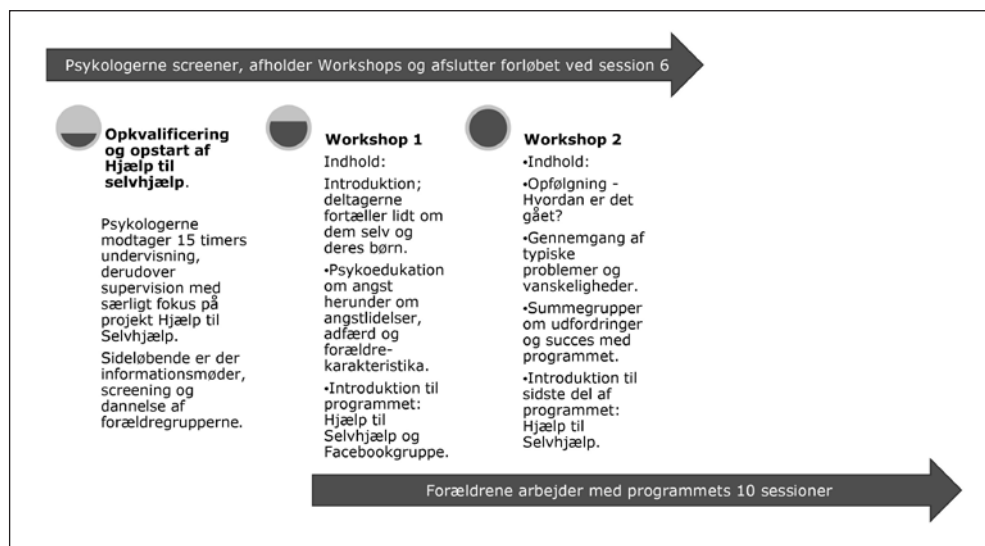
Da arbejdsopgaverne forbundet med projektet som nævnt lå langt fra vores normale PPR-praksis, gav dette i star-ten udfordringer i forhold til tidspriori-tering. Dette var på trods af, at alt det administrative arbejde i forhold til planlægning af, hvor de indledende for-ældremøder skulle afholdes, modtagel-se af henvendelser fra forældre om del-tagelse i projektet, indsamling af spør-geskemaer, oprettelse af grupper, her-under datoer, booking af lokaler til workshops, som nævnt blev varetager af en udviklingskonsulent fra CUP.

Vi fik stillet kamera til rådighed af Center for Angst, og vi optog work-shopsne med henblik på at kunne an-vende disse i supervisionen.

De to workshops

I figuren på næste side fremgå indhol-det af de to workshops. Der er i alt ti sessioner i programmet. Første work-shop dækker 1-5 session, mens anden workshop dækker 6-10. De slides vi fik udleveret af Center for Angst, var bru-gervenligt stillede op, og alt der skulle siges, var præsenteret på disse. I an-den workshop var der færre slides, men mere fokus på udveksling af erfa-ringer (se i øvrigt Christiansen et al. (2017), for yderligere beskrivelse af indholdet af workshops). Det var især i anden workshop, at den indledende træning på Center for Angst var nød-vendig. I disse workshops var der en del spørgsmål, og familierne var på

2 RCADS findes både i en version med 47 items, samt i en kortere version med 15 items. Den kortere version kan anvendes når man ønsker at undersøge generelt angstniveau, hvorimod den større skala er mere anvendelig hvis man ønsker informa-tion inden for de forskellige angstskalet (Ebesutani et al., 2012).



Forløbet omkring opstart og implementering af Hjælp til Selvhjælp.

Vi startede op i august 2016. Der dannes seks grupper med ca. 8 børn repræsenteret. Første workshop ligger i september/oktober og anden workshop ligger i oktober/november.

dette tidspunkt meget forskellige steder. Nogle familier oplevede, at deres barn ikke længere havde symptomerne, der gjorde de tilmeldte sig programmet. Andre oplevede en bedring, men oplevede også at nogle dage var bedre end andre. Enkelte andre var kommet bagud af forskellige årsager, der havde gjort, at de ikke kunne følge programmet. Herefter havde vi ingen

anden kontakt med forældrene end de ugentlige opdateringer på Facebook.

Facebook

Forældrenes brug af Facebook varierede fra gruppe til gruppe. Generelt blev det dog ikke anvendt meget. Tilbage-meldingerne var, at forældrene oplevede, at de ikke kendte hinanden godt nok til at anvende et offentligt medie og udveksle personlige historier omkring deres børn. Der var også en del spørgsmål til, hvor sikkert et medie Facebook er. Det vidner om, at Facebook i forhold til denne forældregruppe er et medie, der måske ikke er anvendeligt til det ønskede formål. Det havde dog den fordel, at psykologerne havde en let tilgang til alle forældre, og med de ugentlige opdateringer nævnte flere forældre, at de blev holdt fast i programmet og motiveret til at fortsætte. Opdateringerne var givet på forhånd af Center for Angst. Det tog tid at få organiseret, at der skulle postes på Facebook hver uge. Dette løste vi ved, at det blev lagt fast i én af psykologerne fra hver workshops kalender.

Forældrenes tilbagemeldinger

På sidste workshop i hver gruppe spurgte vi ind til forældrenes oplevelse af programmet, herunder hvad de havde oplevet som godt ved programmet, samt hvor de oplevede programmet kunne forbedres. Fra de i alt 11 grupper har der overordnet været positive tilbagemeldinger fra forældrene. De har især udtalt sig positivt om programmets opbygning. De har oplevet materialet som forståeligt og anvendeligt. Forældrene lader til at have glæde af, at dele deres oplevelser omkring de-

res børn og møde forståelse fra ligestillede.

Forældrene har oplevet at få en høj grad af ny viden, som de har kunnet overføre og anvende i dagligdagen med børnene. Vores oplevelser har været, at forældrene mødte op til anden workshop med nye perspektiver på egne og børnenes handlinger og tanker. Forældrene var på dette tidspunkt begyndt at agere anderledes over for deres børn, blandt andet ved at støtte dem mere i eksponering. Forældrene har særligt beskrevet det at se børnene deltage i situationer de før ville have undgået, som en væsentlig motivationsfaktor i fastholdelsen af programmet. De fleste forældre har kunnet genkende sig selv i beskrivelserne af forældreadfærd, der kan være medvirkende til udviklingen og fastholdelsen af angst.

Vi har også fået en del tilbagemeldinger om, at HSH er et meget tidskrævende program. Det kræver planlægning i en travl hverdag, og enkelte familier er sprunget fra undervejs, da de oplevede øvrige ting i familien, der gjorde, at de ikke kunne overskue at arbejde med programmet også.

Nogle forældre har også fundet det vanskeligt med den indledende samtale med barnet omkring projektets formål. Dette skyldes at børnene, som oftest ikke har en angstdiagnose, og at familien i nogle tilfælde ikke har haft samtalen med børnene om, hvorfor de skal deltage i projektet.

En stor del af forældrene ville gerne have haft en tredje workshop, da de følte sig mere trygge i gruppen anden gang, og ønskede sparring, når de kom længere hen i programmet. En af ud-

fordringerne ved selvhjælpsprogrammer, kan være opretholdelsen af motivation og gennemførelse programmet. Kontakten med terapeuter kan være en væsentlig del af motivationen og gennemførelsen af selvhjælpsprogrammer (Rapee et al., 2016). Nogle undersøgelser peger på at bedring af angstlidelser i selvhjælpsprogrammer er relateret til, hvor meget terapeuten er involveret (Rapee et al., 2006). Derfor er der grund til at overveje forældrenes ønske om en tredje workshop, da denne måske kan være medvirkende til opretholdelse af motivation, og gennemførelse af programmet, hos de forældre der finder dette vanskeligt.

Børnenes tilbagemeldinger

Børnenes tilbagemeldinger har vi kun gennem forældrene, da vi som beskrevet ikke har været i kontakt med børnene. Hvor forældrene har haft stor glæde af at mødes med andre ligestillede, har børnene været mere alene i deres oplevelser omkring det at have angst. De havde i nogle tilfælde ikke selv valgt at deltage i programmet. Andre børn var mere bevidste om deres vanskeligheder, og var opsatte på at gennemføre programmet. Flere forældre beskrev også, at den tid der skulle bruges sammen med børnene i sessionerne, blev opfattet som positiv af børnene. Derudover fik vi tilbagemeldinger om, at børnene var utroligt stolte hver gang de lykkedes med at gennemføre en eksponeringsøvelse. Enkelte familier droppede ud halvvejs gennem programmet, da barnet ikke længere havde de tidligere vanskeligheder.

Psykologernes oplevelser af projektet

Samlet set har psykologerne alle oplevet, at det var meningsfuldt at være med i projektet. Ud over den faglige opkvalificering, har vi kunnet bidrage til at hjælpe børn med angst, som vi i de senere år har fået en del henvendelser omkring i vores PPR-praksis. Det er ligeledes vores oplevelse, at de værktøjer forældrene får, kan have en positiv effekt for øvrige søskende, der på denne måde får glæde af, at forældrene føler sig mere sikre i deres forældreroller.

Som noget nyt var vi sammen med en kollega i en opgave og havde derfor mulighed for at give hinanden feedback på praksis, hvilket gav meget i forhold til egen læring. Den faglige læring har været mulig at overføre til vores daglige praksis. Dette betyder, at vi nu kan tilbyde forældre til børn med angst samtaler af psykoedukativ karakter.

Som beskrevet i det ovenstående har den positionering, vi har skullet indtage som psykologer, udfordret vores sædvanlige tilgang til vores arbejde. At indtage positioner, der kan virke fremmede, kan være nødvendigt, idet en positionering ikke bør være automatisk, men have sit udgangspunkt i, hvordan vi bedst muligt hjælper borgeren (Schilling, 2017). Vi oplevede, at den positionering vi indtog, var den der var behov for. Forældrene havde behov for psykoedukation omkring angst, flere var usikre og havde også behov for at blive mødt med den sikkerhed og struktur, som programmet og teorien bag, står for. Derudover oplevede vi

også (ud fra forældrenes tilbagemeldinger) at mange af børnene og forældrene udviklede sig undervejs ved at afprøve og turde flere ting, hvilket igen havde en positiv effekt for barnet og den samlede familie. Tilbagemeldingerne om børnenes udvikling, samt den oplevede ændring i forældrenes tilgang, gjorde at vores oprindelige skepsis over for blandt andet forældrene som primære personer i behandlingen, blev afløst af en holdning om at HSH er et relevant og måske tilstrækkeligt program, for en stor del af de børn der deltog i projektet.

Implementeringen af Hjælp til Selvhjælp

Følgende er overvejelser og betragtninger, der kan være relevante at have med såfremt man i samarbejde med Center for Angst ønsker at implementere HSH i en kommune. Når projektet i første omgang skal implementeres, skal man regne med, at der skal afsættes en del tid til de indledende forberedelser. Tiden kan allerede i anden omgang nedjusteres væsentligt for psykologerne, da programmet er brugervenligt med alt information nedfældet og udførlige beskrivelser fra start til slut, hvilket gør at der skal meget lidt forberedelse til, når den indledende træning i metoden er på plads. Dette er en væsentlig tidsbesparelse i forhold til den tid, der tidligere har været anvendt, hvor metoderne og hjælpen måske har været mere uklar, og forskellig fra psykolog til psykolog. Den administrative del vil fortsat fylde en del, og det ville ikke være muligt for os at gennemføre HSH, hvis ikke vi havde en administrativ medarbejder til rådighed.

Szulevicz & Tanggaard (2015) beskriver, at den pædagogiske psykologiske praksis står midt i en identitetskrise. Opgaverne er mange, og det er ikke længere hensigtsmæssigt at fastholde én tilgang til arbejdet. I stedet beskriver de, at det er væsentligt for fremtidens PPR-psykologer at kunne agere pragmatisk og kreativt, ved at kunne bidrage på nye måder og i nye sammenhænge i forhold til opgaveløsningen. HSH har for undertegnede været et eksempel på en sådan opgaveløsning. Det er et færdigt program, og et eksempel på en løsning, der har manglet til et problem, der indtil nu ikke har været muligt at løse på rimelig vis i vores PPR. Hertil vil der formentlig være behov for mindre lokale forskelle, herunder hvordan visiteringen, screening m.m. skal varetages, ud fra den konkrete organisering af psykologerne og deres arbejdsgange i kommunen.

Da HSH er rettet til børn med moderat angst og kræver en del ressourcer af forældrene, vil de forældre, der i forvejen føler sig overvældet af hverdagen, have vanskeligt ved at gennemføre programmet i dets nuværende udformning. Derfor er det vanskeligere at se det implementeret i f.eks. en familieafdeling.

Overvejelser omkring fremtidig implementering

I Lyngby-Taarbæk skal vi gøre os nogle overvejelser omkring den fremtidige implementering. Såfremt det bliver muligt at fortsætte med HSH, vil det være nødvendigt at screeningsprocessen ligges ud til psykologerne, da den ikke længere vil blive varetaget af Center for Angst. Derudover kan det overvejes om

der skal tilføjes en tredje workshop, således, at det sikres, at forældre og børn ikke efterlades, hvis programmet ikke har den ønskede effekt. En implementering kunne se ud, som illustreret af modellen i denne artikel.

Øvrige muligheder for udbredelsen af hjælp til børn og unge med angst

Angstlidelser ses hyppigst fra 5-7 års alderen og frem (Esbjørn et al., 2016b). Der kan være gode grunde til at sætte ind allerede i daginstitutionerne med den psykoedukative del af programmet, da man her måske kan ændre forældreadfærd, inden børnene har udviklet angst. Man skal her være opmærksom på, at når man sætter ind, inden der er opstået symptomer, ser man, at forældrene ikke er særligt motiveret, da motivationen til at handle oftest opstår når vanskelighederne manifesterer sig (Kaminski et al., 2008).

Forældreprogrammer til forældre med teenagere er sjældne, hvilket formentlig skyldes de unges selvstændighed og orientering mod venner som rollemodeller, hvilket kræver en anden tilgang. Ikke desto mindre kan der være fordele ved at inddrage forældrene til teenagere i involvering af forebyggelse og reducere af internaliserende symptomer såsom angst (Yap et al., 2016). I efteråret 2017 bliver projekt HSH i Lyngby-Taarbæk udvidet, således at det går fra 1.-6. klasse. Netop af ovenstående årsag, må der findes andre måder at hjælpe de børn, der ikke er indbefattet af dette.

Yderligere vil det være vigtigt at overveje skolen som en del af implementeringen. Børn tilbringer mange ti-

mer i skolen, og hos nogle af de tilmeldte børn, var angstproblematikken især synlig i skolen. Dette sås fx ved barnets angst for at sige noget højt i timerne, deltagelse i de sociale aktiviteter, og at bruge skolens toiletter. Derfor må skolen være en vigtig aktør i eksponeringen, og viden omkring angst og håndtering af dette, vil være væsentlig at få bredt ud på skolerne. Vi så konkrete tilfælde på dette under programmet, f.eks. ved at forældrene kontaktede skolen, og informerede dem om hvad barnet øvede sig på, f.eks. at række hånden op i timerne, og sammen blev det aftalt hvordan dette kunne gøres på en god måde.

Vi har haft 61 familier, der har gennemført HSH i skoleåret 2016/2017. Ser vi bort fra den indledende opkvalificering, har tre psykologer brugt seksten timer på workshops på et år, mens de to psykologer der stod for den ekstra gruppe i efteråret har brugt tyve timer på workshops. Dertil kommer tidsforbrug i forbindelse med Facebook, samt supervision. Psykologernes oplevelse er, at vi nu giver professionelle og kvalificerede råd og vejledning, som de fleste familier kan bruge. Oplevelsen er også, at vi med få midler, hjælper mange familier med nogle væsentlige ændringer. At både børnene og forældrenes hverdag bliver lettere og præget mere af aldersvarende aktiviteter end angst. Det giver en stor professionel tilfredsstillelse at opleve den forandring, man er med til at skabe.

Jeg har med ovenstående beskrivelser og betragtninger forsøgt at give et billede af, hvordan projekt Hjælp til Selvhjælp har været afprøvet i en PPR-

praksis. Herunder har jeg også forsøgt at give et indblik i den tid og opbakning, der er nødvendig for at projektet er muligt i en kommunal setting, samt hvem der især lader til at have gavn af projektet.

Referencer

- Ebesutani et al. (2012): *The Revised Child Anxiety and Depression Scale-Short Version: Scale Reduction via Exploratory Bifactor Modeling of the Broad Anxiety Factor*. I: Psychological Assessment. Vol. 24, No. 4, 833-845.
- Esbjørn et al. (2016a): *Can Parents Treat their Anxious Child using CBT? A Brief Report of a Self-Help Program*. I: Acta Psychopathologica vol. 2 No.1:10.
- Esbjørn et al. (2016b): *Særligt sensitiv – eller særligt udfordret. En guide til professionelle*. Akademisk forlag.
- Kaminski et al. (2008): *A Meta-analytic Review of Components Associated with Parent Training Program Effectiveness*. Journal of Abnormal Child Psychology. 36: 567-589.
- Kommunernes Landsforening (2013). *Pejlemærker for fremtidens pædagogiske-psykologiske rådgivning*. http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_59605/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
- Rapee et al. (2006): *Bibliotherapy for Children With Anxiety Disorders Using Written Materials for Parents: A Randomized Controlled Trial*. I: Journal of Consulting and Clinical Psychology vol. 74, no.3 p.436-444.
- Rapee et al. (2014): *Hjælp dit ængstelige barn-Trin for trin-guide til forældre*. Dansk psykologisk forlag.
- Psykologeridanmark (2017): <http://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/praktiserende-psykolog/offentlige-tilskudsordninger/>
- Schilling (2017): *Positionering som intervenierende pædagogisk-psykologisk redskab for psykologen i fremtidens PPR*. I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift 54. årgang nr. 1.
- Socialstyrelsen (2017): <https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder>
- Szulewicz & Tanggaard (2015): *Pædagogisk psykologisk praksis – mellem psykometri, konsultation og inklusion*. Hans Reitzels forlag.
- Yap et al. (2016): *Parents in prevention: A meta-analysis of randomized controlled trials of parenting interventions to prevent internalizing problems in children from birth to age 18*. I: Clinical Psychology Review. 50: 138-158.